

Piano esecutivo Venere — Linee guida operative

Sintesi decisionale di tutto ciò stabilito finora. Documento di regia: cosa fare, in che ordine, con quali regole. Riservato.

AGGIORNAMENTO (settembre 2026) · decisioni e novità recepite - Regime = AMBULATORIO. In Lombardia la maggior parte dei trattamenti (iniettivi + laser medicali 3B-4) richiede l'**ambulatorio** (autorizzazione all'esercizio del Comune + parere/sopralluogo ATS via ASAN), non lo studio medico (solo non invasivo). Target: centro estetico **convertibile in ambulatorio** (~90-120 mq, locali distinti, meglio indipendente). - **Focus: SOLO convertire centri estetici** in ambulatori (non comprare cliniche mediche già fatte). Dove si legge "roll-up di cliniche" o "clinica", intendere "roll-up di centri estetici convertiti in ambulatori" / "sede". - **Architettura hub & spoke:** ambulatori hub (invasivo, alto margine) + studi medici satellite (non invasivo, funnel, capex ridotto). - **Bacino:** ~43.000 centri estetici in Italia, ~1.000-1.900 idonei ad ambulatorio (domanda +81% nel 2024). Vedi `Venere_Fattibilita_Ambulatori.md`. - **Marcello Cammalleri = chirurgo maxillo-facciale**, CMO + direttore sanitario (max 3 strutture in Lombardia) + responsabile clinico rete; apre la strada alla chirurgia del volto. - **Direttore Operativo dedicato = assunzione Fase 2** (dopo il pilota validato + seed). - **Sequenza:** prima la **1^a LOI firmata + pipeline** → poi seed €700k (GKSD lead) → scala.

La tesi in una pagina

Cosa: roll-up (buy-and-build) di centri estetici convertiti in ambulatori di medicina estetica mid-small in Italia, gestite con una piattaforma centrale AI-driven. Comprare a **3-4x EBITDA**, creare valore (formalizzazione del nero + recurring + format + scala), uscire a **7-10x** — con l'upside lungo del **data play** (dataset outcome → decision-support → automazione).

Perché questo team: DNA AI (commodity nella consulenza, **scarso e decisivo** qui) + partner clinico credibile (Marcello, chirurgo maxillo-facciale) + capacità di execution M&A.

La mossa doppia: vendere Skylabs a uno strategico entro il 2027 (libera te e il capitale) **e costruire Venere** in parallelo, tenendo le due aziende **separate**.

Il gate go/no-go (Parte A del memo resta aperta): la scelta di fondo Skylabs-vs-Venere va validata sui criteri del memo (durata dei flussi contro AI, competenza scarsa vs commodity, ritorno risk-adjusted, investitori). Questo piano è l'esecuzione **se propendi per Venere**. Non chiudere Skylabs finché la Fase 1 di Venere non è soft-circled.

0. I principi guida trasversali (le regole d'oro)

1. **Aziende separate.** Di Skylabs porti in Venere **l'esperienza, non l'asset**: nessun riuso di codice/IP, nessun accordo commerciale, nessun ponte che possa intaccare la vendita di Skylabs.
2. **Sequenza, non parallelo cieco.** Skylabs non si chiude finché Venere-Fase 1 non è finanziata; gate in sequenza.
3. **Riservatezza sacra** su due fronti: il disimpegno da Skylabs (fino al closing) e il coinvolgimento di Diana in Venere (fino al closing di Skylabs).

4. **Compra il provato, non il nuovo.** Centri estetici con clientela ed EBITDA reali, da convertire in ambulatorio; il valore si crea **operando meglio**.
5. **Una piattaforma, molti nodi** (modello Bending Spoons): il prodotto è la macchina centrale; le cliniche sono nodi. HQ snello ed elitario.
6. **La medicina non si tocca.** La piattaforma gestisce tutto *tranne* l'atto clinico. È il paletto che protegge brand, deontologia e multiplo.
7. **Bianco per costruzione.** Formalizzazione (POS, financing, fatturazione piena) = creazione di valore, non un costo. Zero sconti cash su atti medici.
8. **Front-load.** Pipeline, DD e LOI pronti *prima* dell'ingresso di Diana: a Diana entrato **esegui, non inizi**.

1. I due binari (Skylabs exit Il Venere build) e i gate

	Skylabs (uscita)	Venere (costruzione)
Obiettivo	Vendere a strategico, incassare, liberarti	Fase 1 finanziata + 2-4 sedi closed
Orizzonte	Entro 2027 (picco M&A AI)	Diana entra ~H2'27; scala 2027-28
Gate	Non chiudere finché Venere-Fase 1 non è soft-circled	Non ancorare la raccolta all'exit di Skylabs

Cosa può correre in parallelo: origination/pipeline Venere + pilot demand-side (sui pazienti di Marcello) Il processo M&A Skylabs. **Cosa NO:** closing di acquisizioni Venere (aspettano Diana ~H2'27); rendere visibile il tuo disimpegno o il ruolo di Diana.

2. Skylabs: la vendita (linee guida)

- **A chi:** strategico — **Cegeka Italia o Bip** (chi valorizza pipeline + Partner Program).
 - **Quando:** processo nel **2026-27**, al picco dell'M&A AI, prima che la consulenza AI si svaluti.
 - **Come alzare il prezzo:** pipeline come acceleratore; **Partner Program** come motore di svincolo key-man e retention.
 - **Le 4 regole per non sbagliarlo:** (1) muoviti presto; (2) processo competitivo per il prezzo; (3) **non far trapelare il disimpegno** prima del closing; (4) sciogli il vincolo key-man **prima** (panchina + Partner Program).
 - **Fiscalità:** valuta struttura efficiente (holding personale / PEX) **prima del signing**. Alloca i proventi in tre quote (co-invest Venere / riserva / eventuale Fase 1) **prima** di incassare.
 - **Non mischiare i flussi** Skylabs e Venere (regola related-party).
-

3. Venere: assetto societario (linee guida)

- **Cap table founder:** Luca 59,4% · Diana 22% · COO 12% · Marcello 6,6%.
- **Regola ferrea:** rapporto Luca:Marcello = **9:1** da mantenere anche dopo l'ingresso di nuovi soci.
- **Diana (Chief AI Officer):** entra **dopo la prima acquisizione**, con closing **temporizzato su H2'27** per coincidere con l'uscita da Skylabs (riservatezza). Pre-ingresso: architettura-dati pronta "Diana-ready".

- **Marcello (chirurgo maxillo-facciale, clinical partner part-time):** mantiene la sua pratica; comp ~€240k dalla pratica/flagship, non dalla società. Non ribranda la clinica di Gela (con i fratelli); a Milano/Verona affitta part-time.
 - **Reverse vesting** su tutti i founder operativi (cliff + good/bad leaver).
 - **Nodi legali da chiudere prima di muoverti:** separazione IP da Skylabs (clean-room), patti parasociali (drag/tag/prelazione), struttura MSO.
-

4. Venere: il capitale (quanto, da chi, quando)

- **Chi mette il capitale: investitori**, non i founder. Le prime cliniche NON si comprano coi soldi dei founder.
 - **Sequenza fonti:** (1) **bridge ~100-300k** (pre-seed, per pipeline/pilot/DD); (2) **round Fase 1 ~2,5-4,5M** a valutazione **4-5M**; (3) **debito in Fase 2** (roll-up a leva sui flussi delle cliniche integrate).
 - **Co-invest CEO:** opzionale **0,5-2M** (dai proventi Skylabs), non obbligatorio.
 - **Diritto di co-invest fino al 31/12/27** alla valutazione del primo round (regola da mettere nei patti).
 - **Investitori: GKSD** (conosci il country manager) come strategico possibile, ma **non dipendere da uno solo** — tieni aperti più investitori. **La Farmacia (Hippocrates)** come partner di procurement/scala d'acquisto.
 - **Regola:** la raccolta è **indipendente da Skylabs e non la aspetta**.
-

5. Origination & acquisizione (linee guida)

Profilo target: ricavi **0,8-2,5M**, EBITDA **20%+** (normalizzabile), bacino **100k+**, **1.500+** pazienti, quota iniettabili/ripetibili, **2+ medici** o convertibile a multi-provider, titolare disponibile a **permanenza 24-36 mesi + rollover**, autorizzazioni pulite.

Dove trovarle: **AIDA/Cerved** (ATECO 86.22/86.90 + regione + ricavi) + **registri sanitari regionali + network di Marcello e fornitori** (vie calde) + associazioni/congressi. **Non con Google.**

Funnel: universo → screen finanziario → screen di fit → screen "via calda" → **shortlist A (5-8 target)** per cluster.

Cluster (uno solo per partire): Nord-Ovest (Milano, Torino, Brescia, Bergamo) o **Nord-Est** (Verona-Padova, radici di Marcello). Roma = secondo cluster.

Approccio (mai spaventarli): intro calda + incontro informale tra pari, mai email/visita a freddo. Apre Marcello (medico-a-medico), entri tu con la visione. Ascolta l'80%, capisci la motivazione, **nessun numero sul tavolo** al primo incontro. Contatto **personale e privato**, mai via studio/reception.

Acquisirle in fretta = avere 2-4 deal pronti (sourcing + LOI + DD pre-closing) da chiudere in finestra compressa appena Diana entra. Deal **bilaterali proprietari** (non aste), **template ripetibile**, prime target **semplici**.

6. La struttura dell'offerta al venditore

Prezzo = **3-4x EBITDA normalizzato** (documentato, non il nero). Split:

Componente	Quota	Quando	Funzione
Cash al closing	~60%	subito	liquidità certa
Rollover in Venere	~20-25%	all'exit di gruppo (7-10x)	secondo payday + allineamento
Earn-out	~15-20%	tranche su 2-3 anni	retention + gap di valutazione

- **Earn-out: 3 anni** se il medico è l'asset, **2 anni** se meno dipendente. Legato a EBITDA + permanenza (good leaver).
- **Nero → earn-out:** cash solo sul documentato; il sommerso lo recupera il venditore **via earn-out sull'EBITDA formalizzato** → lo sbianca per guadagnarlo.
- **Paletti:** reverse vesting sul rollover, non-compete, holdback ~10% (12-18 mesi).
- **Flessioni:** pensionando → più cash; giovane ambizioso → più rollover; molto in nero → earn-out più pesante.

Seller pitch (5 messaggi): (1) ricchezza che da solo non avrai (2° payday all'exit); (2) reddito → capital gain (~26% vs ~50%); (3) togliamo il soffitto (brand, recurring, financing); (4) tieni medicina e autonomia (incentivi mai sui volumi); (5) de-risk e successione. **Timing:** i primi prendono le condizioni migliori.

7. Il format (la macchina replicabile — 100 giorni)

Prima sede = format lab. Flagship snello: **affitta uno spazio a Milano e portaci i pazienti di Marcello** (NON comprare l'immobile).

I blocchi da applicare a ogni clinica: - **Recurring da prescrizione:** percorsi di cura annuali a rata mensile (target **15-20% ricavi a 24 mesi, 30% a regime**). - **Membership non medica** (39-59€/mese) come entry point. - **Financing a tasso zero** sui percorsi (alza ticket, apre fascia 25-40, rende il ricavo bianco). - **Patient journey retail:** beauty advisor + consulenza codificata + recall automatici. - **Multi-provider** (depersonalizzazione: il paziente è fedele al brand, non al medico). - **Data layer** instrumentato dalla clinica #1 (outcome 30/90/180, GDPR by design). - **Procurement centralizzato** (sconti volume + partnership La Farmacia; margine 20% → 27%). - **Compliance/MSO:** direttore sanitario per sede, comitato scientifico indipendente, **incentivi mai sui volumi**, audit.

100-day integration: giorni 0-15 governance+gestionale; 15-45 percorsi+membership+financing+beauty advisor; 45-75 secondo medico+mix clinico+procurement; 75-100 brand+KPI a regime.

Cosa testare (demand-side, subito, sui pazienti di Marcello): adozione recurring, conversione, ticket, retention. **Scala-side (su clinica acquisita):** che il valore non dipende dal singolo medico + uplift di margine.

8. Il nero (come affrontarlo, legalmente)

- **"Periodo pulito" pre-acquisizione:** chiedi **6 mesi senza nero** per proiettare l'EBITDA reale a un anno (tecnica di DD).
- **Formalizzazione = value creation:** POS + financing + fatturazione piena rendono tracciabile ciò che era sommerso.
- **Struttura MSO e reddito** → capital gain come leve narrative col venditore.

- **Mai** promettere di preservare il nero. **Impara dall'estero**: la formalizzazione è il motore di sbiancamento che alza il multiplo.

9. Il data play / AI-driven (l'upside lungo)

- **3 livelli**: (1) oggi — moat di qualità (outcome, costo marginale ~zero); (2) medio — **AI decision-support** (riduce dipendenza dal medico, *il medico decide*); (3) lungo (7-15 anni) — **automazione/robotica** di procedure standardizzate.
- **"Venere OS"**: azienda progettata attorno agli agenti (HQ minimo), **alimentata dall'esperienza Skylabs** ma costruita **da zero e pulita** — nessun legame tra le aziende.
- **Guardrail**: i soldi si fanno nel roll-up "noioso"; il data play è **optionality** (alza l'exit verso multipli med-tech/AI, non healthcare-services). Focus oggi = basso, importanza strategica = alta.

10. La governance del tempo (il punto che fa fallire i pivot)

- **Il tuo tempo**: tabella vincolante Skylabs vs Venere; advisor + GM + panchina tengono Skylabs mentre costruisci Venere.
- **Il tempo di Diana (asimmetrico)**: entra tardi (~H2'27) ma su un'azienda già impostata data-ready; pre-ingresso non è visibile.
- **Regola**: l'attenzione divisa uccide — se non c'è una tabella tempi vincolante, uno dei due binari deraglia.

11. Timeline consolidata

Fase	Quando	Skylabs	Venere
1	Set 2026 (M1)	Avvia processo/advisor; panchina	Bridge; team; architettura-dati; origination
2	Ott-Nov 2026 (M2-3)	Info memo; sonda compratori	Pilot demand-side; pipeline+LOI; raccolta Fase 1
3	Dic 2026-H2 2027 (M4-12)	Closing + transizione	Diana entra; closing 2-4 sedi ; format lab
4	2027-28 (M12-24)	(fuori)	Prova del format; scala cluster; debito Fase 2

12. KPI di successo (misura a ~settembre 2027)

- ☐ Skylabs venduta a strategico, tutti incassati, closing fatto
- ☐ Separazione IP e related-party chiuse per iscritto
- ☐ Venere: team completo (Diana + COO), Fase 1 finanziata, **2-4 sedi closed** e in integrazione
- ☐ Tu: full-time su Venere, fuori da Skylabs
- ☐ Format lab: recurring $\geq 10-15\%$, EBITDA/sede $+30\%$, ≥ 2 provider, dataset popolato

13. Rischi trasversali e mitigazioni (sintesi)

Rischio	Mitigazione
Soci Skylabs non allineati sulla vendita	Framing win-win + prezzo da processo competitivo
Rivendica IP gestionale	Separazione IP clean-room chiusa in Fase 1, per iscritto
Skylabs si svaluta	Muoviti nel 2026-27; processo rapido; non trapelare il disimpegno
Fase 1 non si finanzia	Non chiudere Skylabs finché non è soft-circled
Attenzione divisa	Tabella tempi vincolante; advisor+GM tengono Skylabs
Rischio reputazionale clinico	Governance (comitato scientifico, incentivi non sui volumi, audit) dalla clinica #1

14. I documenti da avere pronti per settembre

1. **Deck per i soci Skylabs** sulla vendita congiunta — **senza** menzionare l'arrangement Diana ↔ Venere.
2. **Skylabs info memo** (per l'advisor M&A).
3. **Venere Fase 1 one-pager** (per gli anchor).
4. **Presentazione per Diana** (opportunità + ruolo, senza percentuali) — *pronta*.
5. **Lista target starter + scorecard** — *metodo pronto, da popolare con AIDA + network*.

Numeri chiave a colpo d'occhio

Voce	Valore
Multiplo d'acquisto → exit	3-4x → 7-10x EBITDA
Split offerta	60% cash / 20-25% rollover / 15-20% earn-out
Earn-out	2-3 anni
Permanenza titolare	24-36 mesi + rollover
Raccolta Fase 1	2,5-4,5M a valutazione 4-5M
Bridge pre-seed	100-300k
Co-invest CEO (opz.)	0,5-2M · diritto fino al 31/12/27
Profilo target	ricavi 0,8-2,5M , EBITDA 20%+
Cap table	Luca 59,4 / Diana 22 / COO 12 / Marcello 6,6 (9:1 Luca:Marcello)
Recurring target	15-20% a 24 mesi, 30% a regime
Margine	20% → 27% (procurement)

Documento di sintesi. Per il dettaglio di ogni punto vedi il Piano operativo, il Format Playbook e la Lista Target. Nessuna delle valutazioni della scelta di fondo è "presa": vanno validate sui criteri del

memo.